

1. Пацієнт віком 29 років скаржиться на сильний біль у горлі, утруднене ковтання, обмежене відкривання рота, підвищення температури тіла до 39°C) Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 6-ти днів, лікувався самостійно: приймав протизапальні, полоскав горло ромашкою і пив багато рідини. Голос - гугнявий. Під час орофарингоскопії виявлено: визначається тризм щелеп, гіперемія, інфільтрація та випинання лівої половини м'якого піднебіння, язичок - набряклий, зміщений у здоровий бік. Задньощелепні та підщелепні лімфовузли ліворуч - збільшені, болючі під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

- A. Заглотковий абсцес
- B. Гострий паратонзиліт
- C. Гострий тонзиліт
- D. Паратонзиллярний абсцес
- E. Флегмона ший

2. Під час очищення зовнішнього слухового проходу у пацієнта виникла кровотеча. Яку невідкладну допомогу необхідно надати першочергово?

- A. Промити слуховий прохід, увести марлеву турунду
- B. Шпиталізувати до спеціалізованого відділення
- C. -
- D. Покласти пацієнта на здоровий бік, увести в слуховий прохід стерильну турунду
- E. Покласти пацієнта на здоровий бік, промити слуховий прохід та накласти асептичну пов'язку

3. Пацієнт віком 30 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38°C, незначний біль у горлі. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів. Під час орофарингоскопії виявлено: ротоглотка гіперемована з ціанотичним відтінком, язичок, піднебінні дужки та мигдалики - набряклі, на поверхні мигдалика - суцільні білувато-сірі щільні нальоти, що поширюються на м'яке піднебіння та знімаються шпателем зі значними зусиллями, після їх видалення слизова оболонка кровоточить. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, дещо болючі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий катаральний тонзиліт
- B. Паратонзиллярний абсцес

- C. Агранулоцитарна ангіна
- D. Гострий лакунарний тонзиліт
- E. Дифтерія глотки

4. За яким критерієм оцінюється ступінь тяжкості перебігу гострого тонзиліту?

- A. Температурною реакцією
- B. Рівнем болю в горлі
- C. Генералізованою лімфаденопатією
- D. Регіонарною лімфаденопатією
- E. ШОЕ

5. Пацієнтка віком 43 роки перед проведенням синусліфтингу була спрямована на КТ верхньої щелепи та приносових пазух. За результатами КТ дослідження виявлено: двобічне інтенсивне негомогенне зниження пневматизації обох верхньощелепних пазух та решітчастого лабіринту. Встановлено діагноз: хронічний риносинусит із поліпами. Яке лікування показано пацієнтці?

- A. Функціональна ендоскопічна хірургія синусів
- B. Двобічна гайморо-етмоїдотомія зовнішнім доступом
- C. Двобічна пункція верхньощелепних пазух
- D. Двобічна мікрогайморотомія
- E. Двобічна гайморотомія за Калдвел-Люком

6. Пацієнт віком 40 років скаржиться на зниження слуху на ліве вухо після акустичної травми на виробництві. Під час отоскопії виявлено: барабанні перетинки з обох боків - сіро-перламутрові з вираженими пізнавальними пунктами, інші ЛОР-органи в нормі. За результатами камертональних проб виявлено: Рінне з лівого боку - слабкопозитивний, Вебер - у праве вухо, Швабах - вкорочений із лівого боку. Укажіть тип втрати слуху.

- A. Травматичний
- B. Перцептивний
- C. Кондуктивний
- D. Змішаний
- E. Виробничий

7. Укажіть мінімальний термін тривалості симптомів для встановлення діагнозу: хронічний риносинусит.

- A. 6 місяців
- B. 12 тижнів
- C. 2 роки

- D. 8 тижнів
- E. 20 тижнів

8. Пацієнт віком 32 роки, спортсмен, скаржиться на помірний біль та виражену набряклість лівої вушної раковини, слух не погіршений. Із анамнезу відомо, що початок захворювання пов'язує з отриманням травми під час змагань кілька годин тому. Об'єктивно спостерігається: вушна раковина ліворуч значно потовщена, збільшена, шкіра має ціанотичний відтінок, під час пальпації відзначається флюктуація. Який найімовірніший діагноз?

- A. Отогематома
- B. Забій м'яких тканин
- C. Хондроперихондрит
- D. Абсцес
- E. Бешихове запалення

9. У пацієнта із плоскоклітинним раком вестибулярного відділу гортані T2N1 після хірургічного лікування (надскладкової резекції та шийної лімфаденектомії) під час гістологічного дослідження виявлено: позитивні краї резекції (наявність залишкової пухлини). Яке подальше лікування необхідно провести пацієнту?

- A. Повторна резекція або променева терапія
- B. Паліативна хіміотерапія
- C. Спостереження, при виявленні активного росту - повторна резекція або променева терапія
- D. Спостереження, при виявленні активного росту - радикальна хіміотерапія
- E. Радикальна хіміотерапія

10. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на біль у горлі ліворуч, який турбує протягом останніх 6-ти тижнів. Під час ларингоскопії виявлено: у лівій валекулі візуалізується кратероподібна виразка, що вкрита нальотом біло-сірого кольору, перифокально тканини яскраво-рожевого кольору, інфільтровані. За результатами обстеження встановлено попередній діагноз: рак надголосникового відділу гортані. Протягом якого часу пацієнт повинен бути скерованим до закладу спеціалізованої онкологічної допомоги для подальшого обстеження та проведення спеціального лікування?

- A. Відразу після первинного огляду
- B. Після наступного візиту
- C. Упродовж 1-го місяця після виявлення
- D. Не скеровується взагалі

- E. Упродовж 5-ти днів після виявлення

11. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на зниження слуху на обидва вуха, постійний шум у вухах. Із анамнезу відомо, що хворіє більше 10-ти років, працювала на бавовняному комбінаті в умовах сильного шуму. Отоскопія та інші ЛОР-органи без патологічних змін. Чує шепіт на відстані 2 м кожним вухом. Гірше чує високі звуки. У досліді Вебера латеризація звуку відсутня. Дослід Рінне та Желле - позитивні. Дослід Швабаха - вкорочений. Який найімовірніший діагноз?

- A. Тимпаносклероз
- B. Хронічний двосторонній катар середнього вуха
- C. Хронічна двостороння сенсоневральна приглухуватість
- D. Хронічний двосторонній адгезивний середній отит
- E. Отосклероз

12. На огляд до лікаря-отоларинголога звернувся пацієнт, якого турбує зміна голосу (осиплість) упродовж 2-х місяців. Яке рутинне обстеження повинен провести лікар-отоларинголог у цьому разі?

- A. Електроміографію гортані
- B. Стробоскопію гортані
- C. Непряму ларингоскопію
- D. Пряму ларингоскопію
- E. Рентгенографію гортані

13. Пацієнт віком 26 років скаржиться на відчуття закладеності у вухах і зниження слуху, що з'явилося під час польоту в літаку. Після ковтання, позіхання слух частково відновлюється. Під час отоскопії виявлено: барабанні перетинки з обох боків - сіро-перламутрові з вираженими пізнавальними пунктами, втягнуті, інші ЛОР-органи в нормі. Укажіть анатомічну структуру, у якій відбулося порушення прохідності в пацієнта.

- A. Слухова труба
- B. Носоглотка
- C. Зовнішній слуховий хід
- D. Носова порожнина
- E. Ротоглотка

14. Укажіть ранній симптом злоякісних пухлин середнього відділу гортані.

- A. Захриплість
- B. Утруднення дихання
- C. Кровохаркання
- D. Біль під час ковтання

Е. Парез голосових складок

15. Пацієнт віком 58 років скаржиться на постійний біль у горлі, що посилюється при ковтанні. Під час огляду виявлено: виразкувату пухлину, яка обмежена надгортанником із поширенням на праву валекулу та корінь язика, рухомість голосових зв'язок збережена, праворуч на шії поодинокий лімфатичний вузол до 6 см. Гістологічно було підтверджено плоскоклітинний рак. Укажіть стадію раку гортані згідно з TNM класифікацією.

- A. T2N2Mx
- B. T2N3Mx
- C. T1N0Mx
- D. T2N1M0
- E. T2NxM0

16. Пацієнт віком 48 років скаржиться на затруднене та болісне ковтання рідкої їжі та слини, кашель із рясним мокротинням. Під час ларингоскопії виявлено: у ділянці правого черпакуватого хряща візуалізується інфільтрат, що поширюється на черпакувато-надгортанну складку, у центрі якого визначається неглибока виразка з нерівними краями блідо-рожевого кольору та в'ялогранулюючим дном, голосові складки рожевого кольору, під час фонації змикаються не повністю, голос хриплий. Було проведено MGIT BBL тест, який виявився позитивним. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дифтерія гортані
- B. Туберкульоз гортані
- C. Склерома гортані
- D. Гострий виразковий ларингіт
- E. Рак гортані

17. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на утруднене носове дихання, біль у горлі, зниження нюху та періодичну ринорею протягом 2-х років. Під час огляду носової порожнини виявлено: збільшення розміру носових раковин, ціанотичність слизової оболонки носової порожнини, виділення в носових ходах, у середньому носовому ході правої половини носа візуалізується поліпозне утворення сірого кольору. Який додатковий метод обстеження необхідно призначити в цьому разі?

- A. Комп'ютерну томографію приносових пазух
- B. Магнітно-резонансну томографію навколоносових пазух із контрастуванням

- C. Передню риноскопію та задню риноскопію
- D. Ольфактометрію
- E. Рентгенографію навколоносових пазух

18. Який напрямок завжди має ністагм?

- A. Не залежить від руху ендолімфи
- B. У протилежний до руху ендолімфи
- C. У залежності від руху
- D. Залежно від виду нервової системи
- E. У бік руху ендолімфи

19. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на незначний біль та дискомфорт у горлі ліворуч під час ковтання, неприємний запах з рота. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, температура тіла - 37,2°C. Під час орофарингоскопії виявлено: у ділянці верхнього полюса лівого піднебінного мигдалика візуалізується виразка з нерівними краями, покрита сірувато-жовтим нальотом. Під час пальпації шії ліворуч відзначаються збільшені та болючі лімфатичні вузли. Який найімовірніший діагноз?

- A. Паратонзиллярний абсцес
- B. Сифіліс-асоційований тонзиліт
- C. Ангінa Симановського-Венсана-Плаута
- D. Гострий стрептококовий тонзиліт
- E. Пухлина мигдалика

20. Чим утворена верхня стінка порожнини носа?

- A. Ситоподібною пластинкою решітчастої кістки
- B. Верхньою щелепою
- C. -
- D. Перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки
- E. Виличною кісткою

21. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на погіршення носового дихання, рясні водянисті виділення з порожнини носа, порушення нюху, чхання, слюзотечу. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х років, під час загострень користується топічними деконгестантами, скарги з'являються під час цвітіння трав і дерев. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка порожнини носа набрякла, має ціанотичний відтінок. Інші ЛОР-органи без патології. Який найімовірніший діагноз?

- A. Інтермітуючий алергічний риніт
- B. Хронічний атрофічний риніт
- C. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма

- D. Персистуючий алергічний риніт
- E. Гострий поствірусний риносинусит

22. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на сильний біль у горлі, появу білих нальотів на мигдаликах, які не виходять за межі мигдалика, збільшення та болючість защецепних лімфатичних вузлів, підвищення температури тіла до 38,4°C, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що тиждень тому перехворів на ГРВІ. Під час обстеження виявлено: оцінка за шкалою Мак Айзек - 4 бали, тризм відсутній, експрес БГСА-тест - негативний. Який найімовірніший діагноз?

- A. Інфекційний мононуклеоз
- B. Гострий вірусний тонзиліт
- C. Паратонзиллярний абсцес
- D. Гострий стрептококовий тонзиліт
- E. Гострий бактеріальний тонзиліт

23. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на гнійні виділення з лівої половини носа, підвищення температури тіла до 37,5°C. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом тижня, захворювання пов'язує з перенесеною вірусною інфекцією, під час якої спостерігалися такі симптоми: підвищення температури тіла до 38,8°C, біль у горлі, рясні виділення з носа. На 5-й день температура тіла знизилася, пацієнтка відчула покращення. На 8-му добу загальний стан різко погіршився - знову підвищилася температура тіла до фебрильних значень та з'явилися гнійні виділення з носа. Об'єктивно спостерігається: болючість під час пальпації в ділянці лівої щоки. Під час риноскопії виявлено: слизова оболонка лівої половини порожнини носа гіперемована, набрякла, у лівому середньому носовому ході - смужка гною. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий вірусний риносинусит
- B. Гострий лівобічний бактеріальний верхньощелепний риносинусит
- C. Одонтогенний лівобічний верхньощелепний риносинусит
- D. Гострий лівобічний бактеріальний фронтальний риносинусит
- E. Абсцес носової перегородки

24. Пацієнт віком 49 років скаржиться на осиплість голосу, що турбує протягом року. Із анамнезу відомо, що курить упродовж 28-ми років. Об'єктивно спостерігається: у порожнині глотки патологічних змін немає. Під час непрямої ларингоскопії виявлено: горбистий інфільтрат на лівій голосовій

складці, рухомість обмежена. У підскладковому просторі - без змін. Лікар запідозрив новоутворення гортані. Який метод є обов'язковим у діагностиці раку гортані?

- A. Мікроларингоскопія
- B. Цитологія
- C. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів
- D. Томографія гортані
- E. Біопсія

25. Якою отоскопічно буде барабанна перетинка при секреторному отиті?

- A. Набрякла, ціанотична та випнута
- B. Дещо мутна, з рубцевими змінами
- C. Без змін
- D. Мутна, гіперемована та різко втягнута
- E. Перфорована

26. У пацієнта із плоскоклітинним раком вестибулярного відділу гортані T2 після курсу радикальної променевої терапії виявлено залишкову пухлину. Яке подальше лікування необхідно провести пацієнту?

- A. Радикальна хіміотерапія + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз
- B. Хірургічне видалення + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз
- C. Паліативна хіміотерапія + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз
- D. Повторний курс променевої терапії
- E. Променева терапія + хіміотерапія

27. Десятирічного хлопчика шпиталізовано зі стенозом гортані IV стадії. Визначте оптимальний вид хірургічного втручання.

- A. Трахеостомія
- B. Канюляція трахеї
- C. Конікотомія
- D. Ларингофісура
- E. Інтубація гортані

28. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на закладеність і сухість у носі, носове дихання погіршується в горизонтальному положенні і в задушливому приміщенні. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 6-ти років. Регулярно користується судинозвужувальними краплями, які покращують дихання на 2-3 год. Під час передньої риноскопії виявлено: нижні носові раковини збільшені в об'ємі, носові ходи звужені, слизова оболонка носа ціанотична, місцями на ній визначаються білі плями. Використання судинозвужувальних крапель призводить

до різкого зменшення об'єму носових раковин. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний катаральний риніт
- B. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма
- C. Гострий катаральний риніт
- D. Вазомоторний риніт, алергічна форма
- E. Хронічний гіпертрофічний риніт

29. Як скелетотопічно розташована глотка?

- A. Від VI шийного до III грудного хребця
- B. Від основи черепа до VI шийного хребця
- C. Від II шийного до I грудного хребця
- D. Від IV шийного до II грудного хребця
- E. Від III шийного до II грудного хребця

30. Пацієнт віком 50 років скаржиться на захриплість голосу, неприємні відчуття в горлі, періодичний сухий кашель. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 5-ти років, багато курить, працює на підприємстві з запиленістю повітря. Під час непрямой ларингоскопії виявлено: слизова оболонка голосових складок - рожевого кольору, нерівномірно потовщена, застійний судинний малюнок, рухомість гортані не порушена. Голос хриплий, дихання через гортань не утруднене. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний гіпертрофічний ларингіт, дифузна форма
- B. Склерома гортані
- C. Гострий ларингіт
- D. Злоякісна пухлина гортані
- E. Туберкульоз гортані

31. Пацієнт віком 40 років скаржиться на біль у ділянці лоба, закладеність носа, гнійні виділення з носа. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 5-ти днів, захворювання пов'язує з перенесеним нежитем. Під час передньої риноскопії спостерігається: гіперемія та набряк слизової оболонки в ділянці лівого середнього носового ходу, там же гнійна смужка. За результатами рентгенологічного дослідження виявлено: затемнення лівої лобової пазухи. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий бактеріальний фронтальний риносинусит
- B. Лівобічний гострий гнійний сфеноїдит
- C. Гострий лівобічний гнійний гемісинусит
- D. Лівобічний гострий гнійний етмоїдит

E. Загострення лівобічного гнійного фронтиту

32. Пацієнт віком 35 років скаржиться на утруднене носове дихання у лівій половині носа протягом довгого часу. Під час ендоскопічного обстеження виявлено: утворення білувато-сірого кольору, м'якої консистенції, що виходить із задніх відділів верхньощелепної пазухи та повністю обтурує носоглотку з лівого боку. Який найімовірніший діагноз?

- A. Антрохоанальний поліп
- B. Кіста верхньощелепної пазухи
- C. Етезіонейробластома
- D. Поліпозний риносинусит
- E. Кровоточивий поліп перегородки носа

33. Пацієнтка віком 32 роки, 30 тижнів вагітності, скаржиться на погіршення слуху в лівому вусі протягом декількох місяців. Під час отоскопії виявлено: зовнішній слуховий хід з лівого боку широкий, сірка відсутня, барабанна перетинка сіра, здається витонченою, наявні всі пізнавальні знаки. На аудіограмі спостерігається: кістково-повітряний інтервал до 30 дБ. На тимпанограмі тип As, при визначенні стапедіальних рефлексів відзначаються дискордантні зубці. Який найімовірніший діагноз?

- A. Лівобічна невринома слухового нерва
- B. Гостра лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- C. Прогресуюча лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- D. Лівобічне порушення цілісності ланцюга слухових кісточок
- E. Лівобічний отосклероз

34. Яким епітелієм вистилається носоглотка?

- A. Миготливим багаторядним
- B. Багатошаровим плоским
- C. Багаторядним кубічним
- D. Плоским зроговілим
- E. Однорядним кубічним

35. Із якими з нижченаведених анатомічних утворень межує верхньощелепна пазуха?

- A. Порожниною рота, орбітою, шилоподібним відростком
- B. Порожниною носа, орбітою, соскоподібним відростком

- С. Порожниною носа, собачою ямкою, комірковим відростком верхньої щелепи
- Д. Порожниною рота, орбітою, соскоподібним відростком
- Е. **Порожниною носа, орбітою, комірковим відростком верхньої щелепи**

36. Пацієнт віком 62 роки протягом року лікувався з приводу хронічного гіперпластичного ларингіту. Під час непрямой ларингоскопії виявлено: потовщення, тьмяність та застійна гіперемія голосових складок, поодинокі слизові нальоти. При більш детальному обстеженні фіброскопом виявлена неглибока виразка в ділянці основи надгортанника діаметром 0,6 см із дном, вкритим фібриновим нальотом та судинною ін'єкцією по периферії, яка розповсюджується на праву та ліву голосові складки. Рухомість надгортанника та голосових складок порушена. Під час патогістологічного дослідження біоптату пухлини спостерігається: плоскоклітинний рак. Виявлено збільшення передньошийних лімфатичних вузлів, які мають щільну консистенцію, неоднорідні, не болючі та визначаються окремими конгломератами. Під час проведення ПЕТ-КТ ураження інших органів і систем не виявлено. Який із діагнозів найбільш точно характеризує анатомічну поширеність ураження за класифікацією TNM?

- А. **Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N1, M0**
- В. Рак гортані вестибулярної локалізації T1, N0, M0
- С. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N0, M1
- Д. Рак гортані вестибулярної локалізації T1, N1, M1
- Е. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N1, M1

37. Що таке грушоподібні ямки?

- А. Заглиблення між язиковою поверхнею надгортанника та коренем язика
- В. Інша назва хоан
- С. Заглиблення між передньою та задньою піднебінними дужками
- Д. Заглиблення між вестибулярною та голосовою складками
- Е. **Заглиблення між боковою стінкою глотки та гортанню**

38. У пацієнта під час профілактичного огляду виявили білувато-жовті ріжки' на поверхні піднебінних і язикового мигдаликів, що мають конусоподібну форму, виступають над поверхнею слизової оболонки, не знімаються, щільної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

- А. Фарингомікоз
- В. Мононуклеоз
- С. **Лептотрихоз глотки**
- Д. Дифтерія глотки
- Е. Хронічний (рекурентний) тонзиліт

39. Мати чотирирічної дівчинки скаржиться на те, що дитина погано дихає носом, постійно ходить із відкритим ротом, має частий нежить, хрипіння та зупинки дихання вночі. Об'єктивно спостерігається: згладжені носогубні складки, напіввідкритий рот, змінений прикус. Під час ендоскопічного огляду носа виявлено: слизова оболонка набрякла, глотковий мигдалик повністю перекриває хоани. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гострий тонзилофарингіт
- В. Хронічний назофарингіт
- С. Гіпертрофія глоткового мигдалика I ступеня
- Д. Гіпертрофія глоткового мигдалика II ступеня
- Е. **Гіпертрофія глоткового мигдалика III ступеня**

40. Шестирічна дитина погано дихає носом, часто хворіє на респіраторні захворювання з явищами назофарингіту, сальпінгоотиту, спить із відкритим ротом. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, напіввідкритий рот, високе готичне' піднебіння. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хронічний декомпенсований тонзиліт
- В. Викривлення переділки носа
- С. Ювенільна ангіофіброма носоглотки
- Д. Хронічний гіпертрофічний фарингіт
- Е. **Гіпертрофія глоткового мигдалика**

41. Яким епітелієм вистилається ротоглотка?

- А. Плоским зроговілим
- В. **Багатошаровим плоским**
- С. Однорядним кубічним
- Д. Миготливим багаторядним
- Е. Багаторядним кубічним

42. Між якими хрящами розташована конічна зв'язка?

- A. Черпакуватими
- B. Рожковидними
- C. Клиноподібними
- D. Щитоподібним та перснеподібним
- E. Надгортанником та перснеподібним

43. Військовослужбовець під час виконання завдання унаслідок вибуху отримав акустичну баротравму. Скаржиться на кровотечу з вуха, біль у вусі, шум і порушення слуху. Під час отоскопії виявлено: візуалізується медіальна стінка барабанної порожнини, її слизова оболонка гіперемована. Яку невідкладну допомогу необхідно надати потерпілому?

- A. Промивання вуха розчином фурациліну
- B. Туга тампонада зовнішнього слухового ходу
- C. Вушні краплі з розчином антисептика
- D. Введення турунди з борним спиртом
- E. Введення у слуховий хід стерильної марлевої турунди

44. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, біль у горлі, під час ковтання є болючий порожній ковток, що часто супроводжується болем у вусі. Температура тіла нормальна. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 2-х днів. Під час отофарингоскопії виявлено: слизова оболонка задньої стінки глотки гіперемована, вкрита слизово-гнійним екссудатом, язичок набряклий. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий ларингіт
- B. Гострий фарингіт
- C. Паратонзиліт
- D. Стоматит
- E. Гострий тонзиліт

45. У чотирирічної дитини спостерігаються: утруднення дихання, гавкаючий кашель, осиплість голосу. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів, захворювання почалося з нежитю, кашлю, підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно спостерігається: дитина збуджена, шкіра бліда, в акті дихання бере активну участь мускулатура грудної клітки, відзначається втягування надключичних, підключичних, яремних ямок, міжреберних проміжків та епігастральної ділянки під час вдиху. За результатами ларингоскопії виявлено: слизова оболонка гортані гіперемована, у підскладковому просторі визначаються

валики червоного кольору, голосова щілина різко звужена, під час кашлю виділяється значна кількість гнійного мокротиння. Інші ЛОР-органи - без патології. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дифтерія гортані
- B. Папіломатоз гортані
- C. Гострий ларинготрахеїт
- D. Заглотковий абсцес
- E. Стороннє тіло гортані

46. У п'ятирічного хлопчика спостерігаються такі симптоми: відмовляється від їжі, важко ковтає, голос гугнявий, мовлення нерозбірливе. Із анамнезу відомо, що дитина нещодавно перехворіла на ГРВІ. Об'єктивно виявлено: голова дещо відкинута назад і нахилена вліво, глотка гіперемована, на задній стінці ліворуч відзначається пухлиноподібне утворення, м'яке та болюче на дотик, що переходить у носоглотку. Температура тіла - 38,5°C. Шийні лімфатичні вузли набрякли та болючі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Заглотковий абсцес
- B. Гострий катаральний тонзиліт
- C. Інфекційний моноклеоз
- D. Лівобічний паратонзиллярний абсцес
- E. Аденоїдні вегетації

47. Які лімфатичні вузли є регіонарними для гортані?

- A. Защелепні
- B. Підщелепні
- C. Завушні
- D. Білявушні
- E. Глибокі шийні

48. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на інтенсивний біль у лівому вусі з іррадіацією у ліву скроню, зниження слуху, головний біль, підвищення температури тіла до 38,2°C. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів, захворюванню передувало ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: вушна раковина та зовнішній слуховий хід - без явищ запалення. Пальпація козелка та соскоподібного відростка - безболісна. Під час отоскопії виявлено: ліва барабанна перетинка гіперемована, інфільтрована, без пізнавальних контурів, випинає. Шепіт лівим вухом сприймає на відстані 1,5 м. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний отит з лівого боку
- B. Гострий гнійний середній отит з лівого боку

- С. Лівобічний тубоотит
- Д. Гостра лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- Е. Лівобічний ексудативний отит

49. Пацієнтку віком 58 років шпиталізовано з носовою кровотечею. Із анамнезу відомо, що протягом 15-ти років хворіє на гіпертонічну хворобу, не лікувалася, періодичні носові кровотечі турбують декілька років. Об'єктивно спостерігається: у носовій порожнині - кров'янисті згустки, кірки, АТ - 150/100 мм рт. ст. Під час видалення згустків та кров'яних кірочок з'явилася кровотеча із зони Кіссельбаха. Оберіть найбільш доцільний метод зупинки носової кровотечі.

- А. Задня тампонада носа та гіпотензивна терапія
- В. Передня тампонада носа та гіпотензивна терапія
- С. Топічне застосування інгібіторів фібринолізу та гіпотензивна терапія
- Д. Балонна тампонада носа та гіпотензивна терапія
- Е. Хірургічна зупинка носової кровотечі електрокаутером та гіпотензивна терапія

50. Укажіть епітелій, що вкриває слизову оболонку порожнини носа та приносових пазух.

- А. Багатошаровий однорядний призматичний війчастий
- В. Багатошаровий плоский незроговілий
- С. Однорядний кубічний війчастий
- Д. Однорядний одношаровий призматичний миготливий
- Е. Одношаровий багаторядний призматичний миготливий

51. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на зниження слуху ліворуч та на суб'єктивний шум у лівому вусі. Із анамнезу відомо, що захворіла приблизно 4 роки тому з поступовим зниженням слуху на ліве вухо, пов'язує захворювання з частими гострими вірусними риносинуситами та з гіпертонічними кризами (АТ - до 180 мм рт. ст.). Під час отоскопії спостерігається: обидві барабанні перетинки сірі, блискучі, рухомі. За результатами камертональних проб виявлено: Рінне - '+' на обидва вуха, Вебер - латералізація вправо, Швабах - вкорочений із лівого боку. На аудіограмі спостерігається: зниження як повітряної, так і кісткової провідностей за всією

тональною шкалою на ліве вухо. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хронічна лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- В. Отосклероз
- С. Хронічний двобічний секреторний середній отит
- Д. Хвороба Мен'єра
- Е. Хронічна правобічна сенсоневральна приглухуватість

52. Гілки якого нерва здійснюють чутливу іннервацію носа?

- А. Нюхового
- В. -
- С. Лицевого
- Д. Блукаючого
- Е. Трійчастого

53. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на біль та почервоніння в ділянці лівого очного яблука. Із анамнезу відомо, що протягом останніх 4-х тижнів турбували закладеність носа, односторонні гнійні виділення з носа, головний біль, хворіє на хронічний риносинусит впродовж 5-ти років. Об'єктивно спостерігається: почервоніння та набряк тканин у ділянці внутрішнього краю орбіти ліворуч, незначне обмеження рухливості лівого очного яблука в горизонтальній площині. Гострота зору не змінена. Яке риногенне ускладнення виникло в пацієнта?

- А. Субперіостальний абсцес орбіти
- В. Реактивний набряк повіки
- С. Тромбофлебіт кавернозного синуса
- Д. Абсцес орбіти
- Е. Флегмона орбіти

54. Пацієнт віком 35 років скаржиться на почервоніння, біль та набряклість кінчика носа, що розповсюджується на верхню губу, відповідну половину щоки. Температура тіла - 38°C) Під час риноскопії виявлено: конусоподібне випинання з гнійним стержнем всередині, шкіра навколо утворення - гіперемована, набрякла. Встановлено діагноз: фурункул носа. Яке найбільш тяжке ускладнення може виникнути при фурункулі носа?

- А. Періостит верхньої щелепи, абсцес перегородки носа
- В. Лімфаденіт підщелепної та шийної ділянки
- С. Тромбоз печеристої пазухи, лімфаденіт підщелепної ділянки

D. Тромбоз печеристої пазухи та сепсис

E. Періостит верхньої щелепи, тромбоз печеристої пазухи

55. Пацієнт віком 55 років скаржиться на утруднене носове дихання та періодичні кровотечі через ліву половину носа. Риноскопично спостерігається: у присінку носа візуалізується округле утворення овальної форми з гладкою поверхнею багряного кольору. Під час натискування зондом - кровоточить, м'якої консистенції. Який найімовірніший діагноз?

A. Кровоточивий поліп носової перегородки

B. Естезіонейробластома

C. Антрохоанальний поліп

D. Поліпозний риносинусит

E. Ангіофіброма носоглотки

56. Чоловік віком 55 років працює зварювальником. Курить протягом 25-ти років. Укажіть ризик розвитку раку гортані, а саме: індекс курця (ІК).

A. Група низького ризику виникнення раку гортані

B. Група виражено високого ризику виникнення раку гортані

C. Група високого ризику виникнення раку гортані

D. Група виражено низького ризику виникнення раку гортані

E. Група середнього ризику виникнення раку гортані

57. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на зниження слуху, періодичний біль у вусі з наявністю гнійних виділень, які зникають після закапування антибактеріальних крапель ендаурально. Із анамнезу відомо, що останнє загострення було 6 місяців тому. Під час отоскопії спостерігається: центральна суха перфорація в натягнутій частині барабанної перетинки. На аудіограмі: кістково-повітряний інтервал в 40 Дб, кісткова провідність збережена. За результатами КТ виявлено: відсутність деструкції кістки. Яка тактика лікування пацієнтки?

A. Шунтування барабанної порожнини

B. Тимпанопластика

C. Сануюча операція на середньому вусі

D. Кохлеарна імплантація

E. Консервативне лікування

58. Який буде результат дослідження Швабаха при ураженні звукосприймання?

A. -

B. Вкорочений

C. Позитивний

D. Негативний

E. Подовжений

59. Пацієнту встановлено попередній діагноз: правобічний мастоїдит. Який метод дослідження буде найінформативнішим для підтвердження діагнозу?

A. Рентгенографія скроневої кістки по Стенверсу

B. Рентгенографія скроневої кістки по Шуллеру

C. КТ голови

D. Рентгенографія скроневої кістки по Майєру

E. КТ скроневих кісток

60. Які з нижченаведених артерій беруть участь у кровопостачанні піднебінних мигдаликів?

A. Язикова, лицева, висхідна глоткова та верхньощелепна

B. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та очна

C. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та верхня щитоподібна

D. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та нижня щитоподібна

E. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхня та нижня щитоподібна

61. У двомісячної дитини діагностовано: гостре запалення середнього вуха зліва. Під час натискання на козелок зліва дитина почала кричати та хапатися рукою за ліве вухо. Чим можна пояснити таку реакцію дитини?

A. Недорозвинення перетинчасто-хрящової частини зовнішнього слухового ходу

B. Фізіологічне недорозвинення повітроносних порожнин соскоподібного відростка

C. Фізіологічне недорозвинення кісткової частини зовнішнього слухового ходу

D. Вікові особливості будови барабанної перетинки

E. Вікові особливості будови слухової труби

62. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до 38-38,5°C, утруднене носове

дихання. Із анамнезу відомо, що 7 днів тому пацієнт потрапив у ДТП та отримав травму носа. По медичну допомогу не звертався. Об'єктивно спостерігається: тканини зовнішнього носа набряклі, червоного кольору, пальпаторно безболісні. Під час передньої риноскопії виявлено: з обох боків перегородки носа визначається випинання ціанотично-червоного кольору, м'якої консистенції. Після місцевої анестезії лікарем проведено розтин у ділянці випинання на переділці носа, отримано 3 мл гною. Який найімовірніший діагноз?

- A. Абсцес носової перегородки
- B. Саркома капоші
- C. Перелом лицевого черепа
- D. Посттравматична деформація носа
- E. Гематома носової перегородки

63. Семирічна дитина скаржиться на біль у горлі, слабкість, підвищення температури тіла до 38,5°C. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів. Об'єктивно спостерігається: під час пальпації шийні лімфатичні вузли збільшені, болісні, слизова оболонка ротоглотки гіперемована, піднебінні мигдалики збільшені та покриті нашаруванням. Які додаткові методи обстеження необхідно призначити для диференціювання між вірусною та бактеріальною етіологією захворювання?

- A. Експрес-тест на стрептокок
- B. Кров на антистрептолізин О
- C. Кров на С-реактивний протеїн
- D. Прокальцитонін крові
- E. Загальний аналіз крові

64. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на односторонній біль у горлі, який іррадіює у вухо. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом останніх 3-х днів. За результатами орофарингоскопії виявлено: піднебінний мигдалик праворуч застійно-гіперемований, набряклий, на верхньому полюсі візуалізується виразка, вкрита товстим шаром нальоту брудно-білого кольору, піднебінні дужки праворуч яскраво-рожеві та незначно набряклі, ліворуч - піднебінний мигдалик та піднебінні дужки інтактні. Задня стінка глотки не змінена. Під час огляду інших ЛОР-органів патологічних змін не виявлено. Який збудник найімовірніше спричинив цю форму тонзиліту?

- A. Epstein Barr virus
- B. Симбіоз *Fusobacterium nucleatum* і *Borrelia vincentii*

- C. *Streptococcus pyogenes*
- D. *Corynebacterium diphtheriae*
- E. *Neisseria gonorrhoeae*

65. Під час виконання бойової задачі військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму із втратою свідомості. Об'єктивно спостерігається: утруднене дихання, що супроводжується булькаючими звуками. Які дії необхідно виконати на етапі евакуації відповідно до протоколу MARCH?

- A. Конікотомію
- B. Трахеотомію
- C. Інтраназальне введення назофарингіальної трубки
- D. Потрійний прийом Сафара
- E. Інтубацію трахеї

66. Пацієнт віком 29 років скаржиться на сильний біль у правому вусі, зниження слуху, підвищення температури тіла. Із анамнезу відомо, що тиждень тому хворів на грип. За результатами отоскопії виявлено: візуалізуються міхурці з геморагічним вмістом на шкірі зовнішнього слухового ходу в кістковій частині та на барабанній перетинці праворуч. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бульозний отит
- B. Зовнішній дифузний отит
- C. Фурункул зовнішнього слухового ходу
- D. Синдром Рамзі-Ханта
- E. Туберкульоз вуха

67. Шестирічна дитина скаржиться на біль у правому вусі. Із анамнезу відомо, що тиждень тому перехворіла на ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: дитина дихає ротом та гугнявить, часто перепитує, слизова оболонка носа - рожева, у задніх відділах порожнини носа візуалізується помірна кількість в'язкого слизу, який стікає по задній стінці глотки. Яке обстеження є недоцільним у цьому разі?

- A. Ендоскопія носоглотки
- B. Задня риноскопія
- C. МРТ приносових пазух
- D. Пальцеве дослідження носоглотки
- E. Тимпанометрія

68. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на гнійні виділення з обох половин носа, утруднення носового дихання, головний біль, важкість у ділянці щік, підвищення температури тіла до 38,4°C. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом тижня, захворювання пов'язує із застудою.

Об'єктивно спостерігається: болісність під час пальпації в ділянці щік, слизова оболонка носа гіперемована, набрякла, у середніх носових ходах - смужки гною. За результатами рентгенологічного дослідження виявлено: затемнення обох верхньощелепних пазух. Встановлено діагноз: гострий бактеріальний риносинусит. Яку групу антибактеріальних препаратів необхідно призначити першочергово?

- A. Цефалоспорины другого покоління
- B. **Захищені пеніциліни**
- C. Цефалоспорины третього покоління
- D. Аміноглікозиди
- E. Макроліди

69. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на захриплість голосу, поступове прогресуюче порушення фонації протягом останніх 6-ти місяців. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка - рожева, голосові складки - сірі, на межі передньої та середньої третини лівої складки візуалізується округле, блідо-сіре шароподібне утворення із гладкою поверхнею, величиною як просяне зерно. Рухливість гортані не порушена. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Фіброма гортані**
- B. Туберкульоз гортані
- C. Склерома гортані
- D. Карцинома гортані
- E. Папіломатоз гортані

70. У пацієнтки віком 36 років через 6 місяців після народження дитини виникли напад запаморочення без втрати свідомості, нудота, блювання, спонтанний горизонтальний ністагм, зниження слуху у правому вусі, шум у вусі. Через 3 год напад припинився, ністагм і шум зникли, слух покращився, стан поліпшився. Отоскопічна картина - в нормі. За результатами аудіометричного обстеження виявлено: підвищення порогів сприйняття за повітряною провідністю на низьких частотах, з наявністю кістково-повітряного інтервалу. Пацієнтці було проведено гліцерол-тест, який виявився позитивним. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий лабіринтит
- B. Вестибулярний нейроніт
- C. **Хвороба Менєра**
- D. Доброякісне позиційне пароксизмальне головокружіння
- E. Периферична вестибулопатія

71. До якої анатомічної структури може перейти інфекція у разі фурункула зовнішнього слухового проходу?

- A. **Привушної слинної залози**
- B. Печеристого синусу
- C. Середньої мозкової ямки
- D. Очниці
- E. Підщелепної слинної залози

72. Яке ймовірне ускладнення може виникнути після аплікаційного застосування 75%-го нітрату срібла, який був використаний із метою зупинки носової кровотечі?

- A. Гіпертонічний криз
- B. Стеноз гортані
- C. **Перфорація носової перетинки**
- D. Інфаркт міокарда
- E. Анафілактичний шок

73. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на зниження слуху у лівому вусі, гнійні виділення, біль у ділянці вуха. Із анамнезу відомо, що хворіє з дитинства після перенесеного кору. Періодично відзначає загострення у вигляді виділень, які мають неприємний запах, погіршення слуху. Під час отоскопії спостерігається: незначні гнійні виділення в слуховому ході, барабанна перетинка перфорована у верхньому відділі, сприйняття шепоту - 1,2 м, розмови - 5,0 м. За результатами комп'ютерної томографії виявлено: деструктивні зміни з боку соскоподібного відростка ліворуч. Який найімовірніший діагноз?

- A. Лівобічний хронічний гнійний тубо-тимпанальний отит
- B. Отосклероз
- C. Гострий гнійний середній отит
- D. Хронічна нейросенсорна приглухуватість
- E. **Лівобічний хронічний гнійний епітимпано-антральний отит**

74. У чотирирічної дитини протягом року прогресує дисфонія та утруднення дихання. На біль не скаржиться, загальний стан задовільний. Голос майже беззвучний, при вдиху - залучення яремної ямки. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка - рожева, складки - сірі, рухомі, змикаються не повністю, на них численні вузлики сіро-рожевого кольору, що частково звужують голосову щілину. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гранулематоз із поліангіїтом

- В. Туберкульоз гортані
- С. Папіломатоз гортані
- Д. Пухлина гортані
- Е. Дифтерія гортані

75. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на біль у правому вусі, підвищення температури тіла до 37,8°C. Об'єктивно спостерігається: права вушна раковина відхилена, набряклість у парамеатальній ділянці, біль під час натискання на козелок, у хрящовому відділі - обмежений інфільтрат на задній стінці. Барабанна перетинка перламутрово-сірого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- А. Правобічний мастоїдит
- В. Правобічний гострий середній отит
- С. Правобічний дифузний зовнішній отит
- Д. Правобічний отоантрит
- Е. Фурункул правого зовнішнього слухового проходу

76. Що досліджується під час виконання досліду Тойнбі?

- А. Визначається латералізація звуку
- В. Рухомість стремінця
- С. Пошкодження слуху за звукосприймальним типом
- Д. Прокідність внутрішньої слухової труби
- Е. Пошкодження слуху за звукопровідним типом

77. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на зниження слуху та середньочастотний суб'єктивний шум на обидва вуха. Із анамнезу відомо, що захворіла приблизно 7 років тому після другої вагітності та пологів. Почалася хвороба зі зниження слуху на праве вухо та шуму, 5 років тому приєдналися такі ж симптоми на лівому вусі. Під час отоскопії виявлено: обидві барабанні перетинки - сірі, блискучі, рухомі. За результатами камертональних проб виявлено: Рінне - '-' на обидва вуха, Вебер - вправо. На аудіограмі спостерігається: повітряно-кістковий розрив на обох вухах, більше праворуч, та ніша Кархарта - на 1000 Гц кісткової провідності. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хвороба Мен'єра
- В. Хронічна правобічна сенсоневральна приглухуватість
- С. Хронічний двобічний секреторний середній отит
- Д. Хронічна лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- Е. Отосклероз

78. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на сухість та печію у горлі, утворення сухих кірок на задній стінці горла, більше зранку. Із анамнезу відомо, що відзначає полегшення симптомів після того як поп'є воду, симптоми з'явилися 3 роки тому. Під час огляду виявлено: стоншена слизова оболонка глотки, через яку просвічується сітка кровоносних судин, поверхня глотки вкрита тонким шаром прозорих засохлих виділень. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хронічний атрофічний фарингіт
- В. Дисбіоз глотки
- С. Хронічний (рекурентний) тонзиліт
- Д. Рецидивуючий тонзилофарингіт
- Е. Хронічний гіпертрофічний ларингофарингіт

79. Пацієнт віком 30 років скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до 37,7°C, утруднене носове дихання. Із анамнезу відомо, що впродовж 7-ми днів хворіє на ГРВІ. День тому з'явилося відчуття тиску в правій щоці, що підсилюється при нахилах голови. Під час ендоскопії носа виявлено: слизова оболонка гіперемована, набрякла, в остіомеатальному комплексі праворуч візуалізується гнійний вміст. Яке ускладнення найімовірніше виникло в пацієнта?

- А. Парез лицевого нерва
- В. Гострий бактеріальний риносинусит
- С. Кіста верхньощелепної пазухи
- Д. Ретробульбарний абсцес
- Е. Реактивний набряк щоки

80. Мати семирічного хлопчика скаржиться на те, що в її дитини постійний нежить, відсутнє дихання носом, вночі дитина спить із відкритим ротом і хропить, часом на ранок відзначається блювання. Із анамнезу відомо, що протягом останніх 3-х місяців дитина тричі хворіла на гострий гнійний середній отит. Об'єктивно спостерігається: відкритий рот, згладження носогубної складки. Під час орофарингоскопії виявлено: прикус деформований, готичне піднебіння. Під час риноскопії візуалізується пухлинне утворення носоглотки, що повністю перекриває обидві хоани. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хронічний поліпозний риносинусит
- В. Аденоїдні вегетації
- С. Викривлення носової перегородки
- Д. Ювенільна ангіофіброма носоглотки

Е. Гострий бактеріальний риносинусит

81. Пацієнт віком 40 років повністю втратив слух у лівому вусі впродовж тижня та потрапив до стаціонару з попереднім діагнозом: гостра сенсоневральна приглухуватість, де пройшов лікування системними кортикостероїдами та був виписаний без покращення. Із анамнезу відомо, що напередодні в нього виникали періодичні запаморочення, які продовжувались 2 місяці, поки не з'явилися ознаки парезу лицевого нерва ліворуч. Яке захворювання треба запідозрити першочергово?

- А. Акустичну невриному
- В. Гломусну пухлину
- С. Хворобу Мен'єра
- Д. Раптову сенсоневральну приглухуватість
- Е. Параліч Белла

82. Пацієнтка віком 57 років звернулася до лікаря-отоларинголога зі скаргами на зниження слуху, дзвін у вухах. Із анамнезу відомо, що мати пацієнтки мала двобічну приглухуватість, проте до лікаря не зверталася. Після проведеного огляду та додаткових методів обстеження встановлено діагноз: отосклероз. Яке хірургічне лікування необхідно провести пацієнтці?

- А. Осикуюлопластику
- В. Стапедопластику
- С. Тимпанопластику
- Д. Шунтування барабанної перетинки
- Е. Антромастоїдотомію

83. Пацієнт скаржиться на біль у правому вусі, що посилюється під час пальпації, підвищення температури тіла до 37,6°C. Із анамнезу відомо, що початок захворювання пов'язує з переохолодженням, хворіє 4 дні, раз на рік вимиває сірчану пробку. Під час отоскопії виявлено: зовнішній слуховий прохід звужений, на задній стінці перетинчасто-хрящового відділу візуалізується обмежене випинання з гіперемованою та набряклою шкірою над ним. Барабанну перетинку можна оглянути лише частково, вона сірого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- А. Фурункул зовнішнього слухового проходу
- В. Гострий гнійний середній отит
- С. Сірчана пробка
- Д. Гострий катаральний середній отит
- Е. Катар зовнішнього вуха

84. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на задишку під час незначного фізичного навантаження, захриплість. Із анамнезу відомо, що появу цього стану пов'язує із перенесеною тотальною тиреоїдектомією рік тому. Об'єктивно спостерігається: втягування міжреберних проміжків на вдиху. ЧД - 24/хв, голос практично відсутній. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка - рожева, без набряку, голосова щілина звужена, складки сірі, розташовані парамедіально, нерухомі. Який найімовірніший діагноз?

- А. Посттравматична деформація гортані
- В. Гранулематоз Вегенера
- С. Органічний центральний параліч гортані
- Д. Парез верхнього гортанного нерва
- Е. Парез зворотного гортанного нерва

85. Укажіть місце відкриття нососльозового каналу в носовій порожнині.

- А. Півмісяцева щілина
- В. Верхній носовий хід
- С. Середній носовий хід
- Д. Загальний носовий хід
- Е. Нижній носовий хід

86. Пацієнт віком 38 років скаржиться на біль у правому вусі, гнійні виділення, зниження слуху. Із анамнезу відомо, що хворіє з дитинства після перенесеного кору. Загострення - 2 рази на рік. Під час отоскопії спостерігається: піорея з неприємним запахом, барабанна перетинка перфорована в pars flaccida. Аудіологічно: кондуктивна приглухуватість. За результатами КТ виявлено: деструктивні зміни соскоподібного відростка праворуч. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хронічний мезотимпаніт
- В. Отосклероз, тимпанальна форма
- С. Хронічний епітимпаніт
- Д. Секреторний отит
- Е. Гострий середній отит

87. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано з явищами рясної носової кровотечі, яку неможливо зупинити шляхом назальної тампонади. Із анамнезу відомо, що минулого року переніс ТЕЛА, після цього постійно приймає варфарин, аналіз згортальної системи крові протягом цього періоду не проводився. На момент шпиталізації МНВ (INR) - 18. Який лікарський засіб необхідно застосувати в цьому разі?

- A. Еритроцитарну масу
- B. Протаміну сульфат
- C. Тромбоцитарну масу
- D. 4-факторний концентрат протромбінового комплексу
- E. Свіжозаморожену плазму

88. Із якою великою судиною межує передня стінка барабанної порожнини?

- A. Загальною сонною артерією
- B. Внутрішньою сонною артерією
- C. Зовнішньою сонною артерією
- D. Внутрішньою яремною веною
- E. Хребетною артерією

89. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на інтенсивний біль у правому вусі, з іррадіацією у скроню, зниження слуху, підвищення температури тіла до 38,2°C) Із анамнезу відомо, що хворіє другий день. За результатами отоскопії виявлено: зовнішній слуховий прохід без явищ запалення, барабанна перетинка гіперемована, без пізнавальних контурів, випинає. Пальпація соскоподібного відростка безболісна. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий правобічний середній отит
- B. Секреторний отит
- C. Загострення хронічного мезотимпаніту
- D. Гострий зовнішній дифузний отит
- E. Гострий мастоїдит

90. Пацієнт віком 41 рік скаржиться на наявність пухлини на шиї з лівого боку, відчуття стороннього тіла в глотці протягом 4-х років. Лікувався з приводу підщелепного лімфаденіту. Об'єктивно спостерігається: у ділянці верхньої третини шиї під кутом нижньої щелепи ліворуч виявлено щільно-еластичної консистенції, малорухоме, округле новоутворення розмірами 9,5x7 см. Пульсація загальної сонної артерії відчувається по передньому краю утворення. Під час фарингоскопії спостерігається: асиметрія зівача через випинання бокової стінки глотки ліворуч, розмірами 3x5 см із відтисненням ніші лівого мигдалика до середини. За результатами КТ виявлено: у лівому парафарингеальному просторі візуалізується об'ємне утворення розмірами 86x54x57 мм овальної форми. Контури його чіткі, краї рівні, структурно однорідні, щільність - 28-34 НУ. Новоутворення поширюється від основи черепа до С4. Яка подальша тактика ведення пацієнта?

- A. Пункційна біопсія під контролем ультрасонографії
- B. Діагностична цервікотомія
- C. Біопсія з використанням зовнішнього доступу
- D. Інтракапсулярна енуклеація пухлини через ротову порожнину
- E. Інтракапсулярна енуклеація пухлини зовнішнім доступом

91. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на виражений біль у правому вусі, що іррадіює в зуби та скроню, закладеність вуха, головний біль, підвищення температури тіла до 37,9°C. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів, захворюванню передувало нежить. Об'єктивно спостерігається: вушна раковина не змінена, зовнішній слуховий хід вільний, барабанна перетинка гіперемована, інфільтрована, випинає, пізнавальні орієнтири не визначаються. Пальпація та перкусія соскоподібного відростка безболісна. Шепіт сприймає правим вухом із відстані 1,5 метра. Який найімовірніший діагноз?

- A. Стороннє тіло вуха
- B. Загострення хронічного середнього отиту
- C. Гострий середній отит
- D. Гостра нейросенсорна приглухуватість
- E. Фурункул зовнішнього вуха

92. Пацієнт віком 31 рік скаржиться на біль у правому вусі, зниження слуху, підвищення температури тіла до 38,4°C. Об'єктивно спостерігається: права вушна раковина відстовбурчена, відзначається набряклість та болючість у завушній ділянці, зовнішній слуховий хід звужений у кістковому відділі за рахунок нависання задньо-верхньої стінки. За результатами отоскопії виявлено: барабанна перетинка гіперемована, потовщена, із перфорацією в центральному відділі, з якої синхронно до пульсу виділяється крапля гною (пульсуючий рефлекс). Який найімовірніший діагноз?

- A. Правобічний гострий середній отит, правобічний лабіринтит
- B. Правобічний гострий середній отит, правобічний мастоїдит
- C. Правобічний гострий середній отит, правобічний петрозит
- D. Правобічний гострий середній отит, правобічний отоантрит

Е. Фурункул зовнішнього слухового проходу праворуч

93. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на біль та поколювання з правого боку горла, що посилюється під час ковтання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х днів, симптоми з'явилися після того, як пацієнтка їла смажену рибу. Температура тіла нормальна. Який найімовірніший діагноз?

- А. Стороннє тіло у глотці
- В. Стоматит
- С. Паратонзиліт
- Д. Гострий фарингіт
- Е. Гострий тонзиліт

94. Трирічна дитина вночі несподівано прокинулася. Об'єктивно спостерігається: грубий гавкаючий кашель, дихання шумне, уривчасте, під час вдиху втягуються міжреберні проміжки, губи ціанотичні, голос звучний, температура тіла - 37,3°C. Із анамнезу відомо, що 2-гу добу хворіє на ГРВІ. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гострий геморагічний ларингіт
- В. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- С. Дифтерія гортані
- Д. Скарлатина
- Е. Гострий флегмонозний ларингіт

95. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х днів. Під час орофарингоскопії виявлено: піднебінні мигдалики гіперемовані, набряклі, вогнищево вкриті нальотом білого кольору, піднебінні дужки гіперемовані, набряклі. Лікар провів забір зразків матеріалу на мікробіологічну діагностику, але їхнє транспортування безпосередньо в лабораторію на момент прийому неможливе. Які умови зберігання тампона із зібраним матеріалом?

- А. Зберігати тампон у термостаті при температурі 20°C максимум 24 год
- В. Зберігати тампон у холодильнику при температурі 4-6°C, доки не відкриють лабораторію
- С. Зберігати тампон у термостаті при температурі 37°C максимум 12 год
- Д. Зберігати тампон у термостаті при температурі 37°C, доки не відкриють лабораторію
- Е. Зберігати тампон у холодильнику при температурі 4-6°C максимум 12 год

96. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на запаморочення, порушення координації та ходьби, виражений шум і зниження слуху в лівому вусі, виділення з цього вуха з неприємним запахом. Із анамнезу відомо, що хворіє приблизно 37 років, періодично лікувався амбулаторно консервативними засобами (туалет, вушні краплі та антибіотики) з нетривалим ефектом. Три дні тому виникли запаморочення та порушення координації, які швидко прогресували. Під час отоскопії виявлено: у лівому зовнішньому слуховому ході - гнійні виділення з неприємним запахом, перфорація у розслабленій частині барабанної перетинки. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хвороба Мен'єра
- В. Лівобічний хронічний епітимпаніт, лівобічний лабіринтит
- С. Лівобічний хронічний мезотимпаніт, лівобічний лабіринтит
- Д. Лівобічний хронічний епітимпаніт, абсцес скроневої частки мозку
- Е. Отосклероз

97. У якому квадранті барабанної перетинки виконують парацентез або тимпанотомію?

- А. У задньо-нижньому
- В. У двох передніх
- С. У передньо-верхньому
- Д. У задньо-верхньому
- Е. У передньо-нижньому

98. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на те, що її дворічна дитина (дівчинка) досі не почала говорити. Під час отоскопії спостерігається: обидві барабанні перетинки сірі, блискучі, рухомі. За результатами тимпанометрії виявлено: крива типу 'A'. Інші об'єктивні способи перевірки слуху (реєстрація КСВП та отоакустична емісія) виявили повну глухоту на обидва вуха. Який спосіб лікування дитини необхідно рекомендувати цій пацієнтці?

- А. Оперативне втручання - кохлеарну імплантацію
- В. Термінове консервативне лікування
- С. Оперативне втручання - стапедопластику
- Д. Слухопротезування
- Е. Відмовитися від будь-якого лікування

99. З якими із нижченаведених пар черепних нервів межує клиноподібна пазуха?

- A. III, IV, V, X
- B. III, V, VI, X
- C. II, IV, V, VII
- D. II, III, V, VI
- E. III, IV, V, VI

100. Пацієнт віком 56 років скаржиться на захриплість голосу протягом місяця, біль під час ковтання. Із анамнезу відомо, що курить упродовж 40 років, часто вживає алкогольні напої. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка гортані рожевого кольору, волога, нальоту немає, права голосова складка нерівномірно потовщена, бугриста, обмежено рухлива, під час фонації складки змикаються неповністю. Голос хриплий, дихання вільне. Під час пальпації шийних та надключичних лімфатичних вузлів відзначається полілімфаденопатія. Який найімовірніший діагноз?

- A. Рак гортані
- B. Парез голосових складок
- C. Папіломи гортані
- D. Туберкульоз гортані
- E. Хронічний ларингіт

101. Пацієнт віком 60 років скаржиться на дискомфорт у горлі при ковтанні, скарги тривають кілька місяців. Під час огляду виявлено: вільний край надгортанника, більше праворуч, пророслий горбисто-виразкуватою пухлиною, рухомість голосових зв'язок збережена, просвіт гортані для дихання достатньо широкий, справа на шії в місці біфуркації загальної сонної артерії поодинокий обмежено-рухомий лімфатичний вузол до 3 см. Гістологічно підтверджено плоскоклітинний рак. Укажіть стадію раку гортані згідно з TNM класифікацією.

- A. T1NxM0
- B. T2N2Mx
- C. T1N1Mx
- D. T1N0Mx
- E. T2N1M0

102. Де знаходяться валекули?

- A. У грушоподібних ямках
- B. Між боковою стінкою глотки та гортанню
- C. Між вестибулярною та голосовою складками

D. Між язиковою поверхнею надгортанника та коренем язика

E. Між черпакувато-надгортанною складкою та боковою стінкою гортані

103. Пацієнт віком 30 років скаржиться на утруднене носове дихання, гнійні виділення з носа, розпираючий біль у правій половині обличчя, головний біль. Під час передньої риноскопії виявлено: слизова оболонка носа гіперемована, набрякла, у середніх носових ходах є смужка гною. Які приноскові пазухи можуть бути уражені в пацієнта?

- A. Клиноподібна пазуха, задні решітчасті комірки
- B. Лобова пазуха, клиноподібна пазуха, середні решітчасті комірки
- C. Верхньощелепна пазуха, передні решітчасті комірки
- D. Передні, задні решітчасті комірки
- E. Лобова пазуха, верхньощелепна пазуха, передні решітчасті комірки

104. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на різкий стріляючий біль у вусі з лівого боку, зниження слуху, шум. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 2-х днів. За результатами отоскопії виявлено: барабанна перетинка різко випнута, гіперемована, набрякла. Проби на прохідність внутрішньої слухової труби негативні. Укажіть характерні зміни, які спостерігатимуться в цього пацієнта під час аудіометрії лівого вуха.

- A. Розрив між кістковою та повітряною провідністю, при нормальній кістковій провідності
- B. Обидві криві ідуть по діагоналі вниз
- C. Повітряна провідність залишається в нормі на високих частотах
- D. Кісткова та повітряна провідність знижуються симетрично
- E. Розрив між кістковою та повітряною провідністю, при зниженій кістковій

105. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на виражену закладеність носа, слизово-гнійні виділення з носа, відчуття тиску в проекції приноскових пазух, виражений головний біль, підвищення температури тіла до 38°C. Із анамнезу відомо, що хворіє 11-й день за останній рік мала 3 подібні епізоди гострого захворювання носа, з приводу яких призначалися антибактеріальні препарати. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий післявірусний риносинусит
- B. Загострення хронічного гнійного риносинуситу
- C. Гострий бактеріальний риносинусит
- D. Рецидивуючий риносинусит
- E. Гострий вірусний риносинусит

106. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на жовто-зелені виділення з лівої половини носа з неприємним запахом, відчуття тиску в ділянці лівої щоки. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 10-ти днів, приблизно 3 тижні тому успішно пролікувалася з приводу лівобічного гаймориту. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, температура тіла - 37,5°C) Під час огляду ротової порожнини виявлено каріознозмінений 2-й моляр з лівого боку. Під час риноскопії спостерігається: у середньому носовому ході з лівого боку - гнійні виділення з неприємним запахом, слизова оболонка носа - гіперемована, набрякла. Який найімовірніший діагноз?

- A. Алергічний риніт
- B. Стороннє тіло в носовій порожнині
- C. Вазомоторний риніт
- D. Одонтогенний верхньощелепний синусит
- E. Антрохоанальний поліп

107. Пацієнт віком 37 років скаржиться на різке утруднення дихання через обидві половини носа, тяжкість у голові. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 7-ми років. Під час передньої риноскопії спостерігається: поліпи в середніх носових ходах, там же гнійні виділення. За результатами рентгенологічного обстеження виявлено: затемнення комірок решітчастого лабіринту з обох боків. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний двобічний гнійний етмоїдит
- B. Хронічний двобічний поліпозний верхньощелепний синусит
- C. Хронічний двобічний поліпозно-гнійний фронтит
- D. Хронічний двобічний етмоїдальний риносинусит з поліпами
- E. Хронічний двобічний поліпозний етмоїдит

108. Пацієнт віком 28 років скаржиться на сильний біль у горлі, біль під час ковтання слини та їжі, підвищення температури тіла до 39°C. Під час орофарингоскопії виявлено: рот відкривається вільно, передні піднебінні дужки - гіперемовані, набряклі, піднебінні мигдалики збільшені, червоного

кольору, на їх поверхні є біло-жовтий наліт, що не поширюється за межі мигдалика та легко знімається шпателем. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дифтерія глотки
- B. Паратонзиллярний абсцес
- C. Гострий катаральний тонзиліт
- D. Хронічний тонзиліт
- E. Гострий тонзиліт

109. Під час активних ворожих дій на лінії розмежування бойовий медик помітив, що його побратим гучно закричав та впав на землю. За декілька секунд одяг пораненого в ділянці ноги почав просякати кров'ю. Який перший крок повинен виконати бойовий медик у цьому разі?

- A. Провести непрямий масаж серця
- B. Накласти турнікет потерпілому
- C. Подбати про безпечність місця надання допомоги
- D. Очистити дихальні шляхи від сторонніх предметів
- E. -

110. Які основні симптоми тимпанального отосклерозу?

- A. Прогресуюче зниження слуху, середньочастотний шум
- B. Гноєтеча з вуха, прогресуюче зниження слуху, низькочастотний шум
- C. Нормальний слух, високочастотний шум
- D. Глухота, відсутність шуму
- E. Флюктуюче зниження слуху, низькочастотний шум

111. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на запаморочення, хиткість під час ходьби, слизисто-гнійні виділення з правого вуха. Із анамнезу відомо, що періодичні гнійні виділення з правого вуха турбують протягом 20-ти років. Два дні тому збільшилися слизисто-гнійні виділення з неприємним запахом у правому зовнішньому слуховому ході, вперше з'явилися запаморочення та хиткість ходи. Під час отоскопії виявлено: у зовнішньому слуховому ході праворуч візуалізуються слизисто-гнійні виділення з неприємним запахом, барабанна перетинка - рожева з крайовою перфорацією в передньоверхньому квадранті. Виявлена позитивна фістульна проба, горизонтальний дрібнорозмастиий ністагм під час погляду вправо. Під час ходьби відхиляється вліво, у позі Ромберга

падає вліво, при повороті голови напрямок падіння змінюється. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний гнійний епітимпаніт праворуч, ускладнений гострим серозним обмеженим лабіринтитом
- B. Хронічний гнійний епітимпаніт праворуч, ускладнений абсцесом мозочка
- C. Хронічний гнійний ексудативний отит, ускладнений обмеженим лабіринтитом
- D. -
- E. Хронічний гнійний мезотимпаніт праворуч, ускладнений обмеженим лабіринтитом

112. До лікаря-отоларинголога звернулася мати із п'ятирічною дитиною зі скаргами на те, що дитина постійно ходить із відкритим ротом, погано дихає носом, має часто нежить, хрипить. Під час ендоскопічного огляду виявлено: аденоїд повністю перекриває хоани. Алергічний анамнез не обтяжений. Який найімовірніший діагноз?

- A. Атрезія хоан
- B. Гіпертрофія аденоїда 4-ї стадії
- C. Хронічний назофарингіт
- D. Гіпертрофія аденоїда 3-ї стадії
- E. Аденоїдит

113. Пацієнт віком 60 років скаржиться на колючий біль під час ковтання. Із анамнезу відомо, що скарги пов'язує із вживанням риби годину тому. За результатами фарингоскопії стороннє тіло не виявлено. Під час ларингоскопії в правій валекулі візуалізується риб'яча кістка. Яким способом необхідно видалити стороннє тіло?

- A. Горловим корцангом при прямій ларингоскопії
- B. Горловим корцангом при фарингоскопії
- C. Горловим корцангом при непрямій ларингоскопії
- D. Зовнішнім доступом
- E. Видалення кістки не є обов'язковим

114. Із якою анатомічною структурою межує передня стінка зовнішнього слухового проходу?

- A. Привушною залозою
- B. Середньою черепною ямкою
- C. Соскоподібним відростком
- D. Суглобом нижньої щелепи
- E. Барабанною перетинкою

115. У пацієнта віком 30 років виявлено ознаки правобічного гострого бактеріального верхньощелепного риносинуситу. Із анамнезу відомо, що захворів тиждень тому після переохолодження. Іншої патології не виявлено. Про який шлях інфікування приносової пазухи, найімовірніше, йдеться в цьому разі?

- A. Одонтогенний
- B. Риногенний
- C. Травматичний
- D. Гематогенний
- E. Лімфогенний

116. Пацієнт віком 28 років скаржиться на раптову втрату слуху на ліве вухо після санації зовнішнього слухового ходу вушною паличкою. Об'єктивно спостерігається: лівий зовнішній слуховий хід обтурований сірчаними масами. За результатами камертональних проб виявлено: Рінне ліворуч негативний, Вебер у ліве вухо, Швабах подовжений з лівого боку. Укажіть тип втрати слуху.

- A. Обтуративний
- B. Кондуктивний
- C. Перцептивний
- D. Побутовий
- E. Змішаний

117. Де знаходиться більшість кавернозної тканини у порожнині носа?

- A. Нижній носовий раковині
- B. Присінку носа
- C. Перегородці носа
- D. Середній носовий раковині
- E. Верхній носовий раковині

118. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на зниження слуху на праве вухо, постійні виділення з нього, двоїння в очах, сильний біль у глибині правого ока, підвищення температури тіла до 38,9°C. Із анамнезу відомо, що захворювання почалося 2 тижні тому з підвищення температури тіла до 38°C, нежиттю та болу у вусі. Лікувалася самостійно вушними краплями. Відучора стан погіршився, з'явилися скарги на біль в оці та двоїння. Об'єктивно спостерігається: у слуховому ході гнійні виділення, барабанна перетинка застійно-гіперемована, інфільтрована, наявний пульсуючий світловий рефлекс. Завушна ділянка візуально не змінена, пальпація та перкусія безболісні. Очні щілини D=S, рух правого ока назовні різко обмежений. Яке отогенне ускладнення можна запідозрити?

- A. Петрозит**
- B. Абсцес орбіти**
- C. Нейропатія око рухового нерва**
- D. Тромбоз кавернозного синуса**
- E. Мастоїдит Чителлі**

119. У п'ятирічної дитини спостерігається утруднення дихання, що з'явилося після випадкового вдиху насіння квасолі. Відразу з'явилося наростаюче утруднене дихання та ціанотичність кінцівок. Лікар провів прийом Геймліха, проте він виявився неефективним. Об'єктивно спостерігається: стан дитини тяжкий, дихання різко утруднене, поверхнєве, шумне, відзначається втягіння міжреберних проміжків, епігастральної ділянки над- і підключичних ямок. Пульс частий зі слабим наповненням, шкірні покриви ціанотичного кольору, вологі. Яка тактика лікування дитини в цьому разі?

- A. Киснева маска**
- B. Інтубація трахеї**
- C. Ургентна трахеостомія**
- D. Введення кортикостероїдів внутрішньовенно**
- E. Введення адреналіну внутрішньовенно**

120. Пацієнт віком 47 років скаржиться на хрипіння, періодичні в'язкі виділення, що затікають із носоглотки. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися 5-6 місяців тому, пов'язує зі зміною роботи - працює на будівництві, часто переохолоджується. Неодноразово звертався до сімейного лікаря, лікувався судинозвужувальними краплями у ніс, протизастудними комплексними препаратами. Покращення стану після лікування короткочасне. Об'єктивно спостерігається: носове дихання утруднене з обох боків, нюх - знижений, носова перегородка - по середній лінії, слизова оболонка носа - застійно-рожева, набрякла, після анемізації - скорочується. Виділення мутні жовтуваті, переважно в задніх відділах носової порожнини. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний риносинусит без поліпозу носа**
- B. Хронічний неалергічний риніт**
- C. Хронічний назофарингіт**
- D. Гострий рецидивуючий риносинусит**
- E. Алергічний риніт (холодова алергія)**

121. Пацієнт віком 28 років скаржиться, що з дитинства часто хворіє на гострий тонзиліт. Із анамнезу відомо, що 3 роки тому гострий тонзиліт ускладнився

ревматизмом з ураженням серця та суглобів, із приводу чого пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні. Під час фарингоскопії виявлено: гіперемія передніх піднебінних дужок, мигдалики спаяні з піднебінними дужками, у лакунах - гнійний вміст. Підщелепні лімфатичні вузли ущільнені. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний декомпенсований тонзиліт**
- B. Хронічний субкомпенсований тонзиліт**
- C. Хронічний компенсований тонзиліт**
- D. Хронічний фарингіт на фоні ГЕРХ**
- E. Ревматоїдна ангіна**

122. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на біль у вусі. Із анамнезу відомо, що хворіє 2 дні, скарги виникли після самостійного видалення сірки зі слухового ходу ватними паличками. Об'єктивно спостерігається: вушна раковина не змінена, під час натискування на козелок виникає різкий біль. Під час отоскопії виявлено: гіперемія та дифузна інфільтрація шкіри зовнішнього слухового ходу, барабанна перетинка гіперемована по краю, слух не порушений. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дифузний зовнішній отит**
- B. Фурункул зовнішнього вуха**
- C. Загострення хронічного середнього отиту**
- D. Екзема зовнішнього слухового проходу**
- E. Стороннє тіло вуха**

123. Пацієнт віком 27 років скаржиться на виражений біль у лівому крилі носа, набряк тканин, що розповсюджується на щоку та нижню повіку з лівого боку, підвищення температури тіла до 38,1°C. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 2-х днів. Об'єктивно спостерігається: шкіра в ділянці зовнішнього носа ліворуч інфільтрована, гіперемована, напружена, різко болюча під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бешиха зовнішнього носа**
- B. Фурункул носа**
- C. Тромбоз кавернозного синуса**
- D. Сикоз присінка носа**
- E. Реактивний набряк повіки**

124. Пацієнт віком 28 років скаржиться на сильний біль у горлі, що посилюється під час ковтання, головний біль, підвищення температури тіла до 37,9°C, періодичний кашель. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів. Під час огляду глотки

виявлено: симетричне збільшення та гіперемія піднебінних мигдаликів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий фарингіт
- B. Гострий бактеріальний тонзиліт
- C. Паратонзиліт
- D. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів
- E. **Гострий вірусний тонзиліт**

125. У пацієнта віком 47 років 2 тижні тому з'явився набряк, почервоніння повік правого ока, сильний головний біль, підвищення температури тіла до 38,5°C. Із анамнезу відомо, що хворіє на цукровий діабет, протягом попередніх 5-ти днів лікувався з приводу загострення хронічного правобічного гемісинуїту. Об'єктивно спостерігається: ознаки правобічного гнійного гемісинуїту, екзофтальм, хемоз, офтальмоплегія правого ока, відсутність корнеальних та зіничних рефлексів, функціональні розлади зору. Яке риногенне ускладнення виникло у пацієнта?

- A. **Флегмона орбіти**
- B. Реактивний набряк повіки
- C. Остеоперіостит орбіти
- D. Субперіостальний абсцес орбіти
- E. Ретробульбарний абсцес

126. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на утруднення носового дихання, сухість у горлі, охриплість, постійне відхаркування кірок. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 15-ти років. Під час риноскопії та фарингоскопії виявлено: сухі кірки, інфільтрати та рубцеві зміни слизової оболонки. Під час ларингоскопії виявлено: гіперемія слизової оболонки, кірки на голосових складках, інфільтрат під правою голосовою складкою. Який найімовірніший діагноз?

- A. Туберкульоз гортані
- B. Папіломатоз гортані
- C. Гранулематоз із поліангіїтом
- D. Дифтерія гортані
- E. **Склерома гортані**

127. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на зниження слуху на обидва вуха, шум у вухах. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися 5 років тому після пологів. Об'єктивно спостерігається: з обох боків зовнішні слухові ходи широкі, шкіра слухового ходу стоншена, сірка відсутня. Під час огляду барабанної перетинки з обох боків - позитивний симптом рожевої плями. Інші ЛОР-органи - без патології.

Шепіт чує: праве вухо - 1 м, ліве вухо - 1 м. Дослід Рінне - 'з обох боків. На тональний аудіограмі: кістково-повітряний розрив до 40 дБ при нормальній кістковій провідності на обох вухах. Який найімовірніший діагноз?

- A. Двобічна хронічна сенсоневральна приглухуватість
- B. Двобічна хронічний ексудативний отит
- C. Отосклероз, кохлеарна форма
- D. Двобічний хронічний катар середнього вуха
- E. **Отосклероз, тимпанальна форма**

128. Пацієнт віком 40 років скаржиться на відчуття подряпання та лоскотання в горлі, сухий кашель, захриплість і швидко втомлюваність голосу. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 2-х днів. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, температура тіла - 37,6°C, голос хриплий, дихання через гортань не порушене. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка гортані різко гіперемована, на її поверхні - невелика кількість в'язких виділень, голосові складки інфільтровані, рухомість їх не змінена. Інші ЛОР-органи - без особливостей. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Гострий катаральний ларингіт**
- B. Дифтерія гортані
- C. Хондроперихондрит гортані
- D. Набряк гортані
- E. Загострення хронічного катарального ларингіту

129. У трирічної дитини вночі виник напад задишки. Із анамнезу відомо, що дитина перехворіла на ГРВІ, проте останні два дні самопочуття було задовільним, температура тіла нормалізувалася. Об'єктивно спостерігається: стан дитини тяжкий, дихання часте, поверхнєве, в акті дихання бере участь допоміжна мускулатура грудної клітки, наявний ціаноз шкірних покривів. Раптово під час огляду дитина перестала дихати. Між якими анатомічними структурами ший необхідно провести розтин для виконання конікотомії?

- A. Між щитоподібним хрящем і під'язиковою кісткою
- B. Між щитоподібним хрящем і надгортанником
- C. Між першим та другим кільцем трахеї

- D. Між дугою перснеподібного хряща та першим кільцем трахеї
 E. Між дугою щитоподібного та перснеподібного хрящів

130. У пацієнта віком 30 років під час проведення камертонального дослідження виявлено: Швабах подовжений. Який тип ураження слуху в цього пацієнта?

- A. Ураження звукопроведення
 B. Ураження мозочка
 C. Змішана приглухуватість
 D. Ураження звукосприйняття
 E. Ураження стовбура мозку

131. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на постійну охриплість та утруднення дихання під час респіраторних вірусних захворювань. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися два роки тому, після струмектомії з приводу вузлуватого зоба. Об'єктивно спостерігається: ліва голосова складка білого кольору, нерухома під час фонації та дихання, права голосова складка активно рухається. Який найімовірніший діагноз?

- A. Параліч лівого зворотного нерва
 B. Параліч правого передньо верхнього гортанного нерва
 C. Параліч лівого переднього верхнього гортанного нерва
 D. Параліч правого зворотного нерва
 E. Параліч лівого заднього верхнього гортанного нерва

132. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на відчуття сухості, подряпання, лоскотання в носі, чхання, підвищення температури тіла до 38,2°C. Із анамнезу відомо, що хворіє 1 день. Під час передньої риноскопії виявлено: слизова оболонка носа гіперемована, суха, набрякла. Дихання через ніс дещо утруднене. Інші ЛОР-органи без патології. Який найімовірніший діагноз?

- A. Загострення хронічного катарального риніту
 B. Гострий ринофарингіт
 C. Гострий травматичний риніт
 D. Вазомоторний риніт, алергічна форма
 E. Гострий вірусний риносинусит

133. Яким епітелієм вкрита слизова оболонка дихальної частини порожнини носа?

- A. Багаторядним циліндричним миготливим

- B. Багатошаровим плоским
 C. Одношаровим плоским
 D. Специфічним нюхальним
 E. Зроговілим плоским

134. Пацієнтка віком 49 років захворіла раптово, коли вночі з'явився виражений головний біль, який не знімався анальгетиками. На ранок пацієнтка відзначила прогресуюче зниження зору та набряк шкіри навколо очей. Із анамнезу відомо, що протягом 7-ми років хворіє на хронічний риносинусит із періодичними загостреннями. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, рівень свідомості - сопор, АТ - 160/90 мм рт. ст., температура тіла - 39,2°C, обличчя пастозне, різко виражений птоз повік, наявний двобічний екзофтальм, двобічна офтальмоплегія, хемоз і крововиливи в кон'юнктиву. Виявлено ригідність потиличних м'язів та слабко позитивний симптом Керніга з обох боків. Лице без чітких асиметрій. Активні рухи в кінцівках ослаблені, без чіткої різниці боків. Тонус дифузно знижений. Рефлекси кінцівок торпідні D=S. На больові подразники реакція послаблена. Під час люмбальної пункції отримано 5 мл білуватого мутного ліквору. Встановлено діагноз: гострий бактеріальний пансинусит. Які ускладнення виникли у пацієнтки?

- A. Гнійний менінгоенцефаліт. Двобічний тромбоз кавернозного синуса
 B. Двобічний тромбоз кавернозного синуса. Абсцес фронтальної долі головного мозку
 C. Гнійний менінгоенцефаліт. Набряк Квінке
 D. Гнійний менінгоенцефаліт. Флегмона орбіти
 E. Двобічний ретробульбарний абсцес

135. Пацієнт віком 40 років скаржиться на закладеність у вухах, що виникла на фоні нежиттю. За результатами акустичної тимпанометрії виявлено: наявність негативного тиску в порожнині середнього вуха - -250 мм вод. ст. Для якого типу кривої характерна наявність від'ємного тиску в барабанній порожнині?

- A. C
 B. A
 C. D
 D. B
 E. Ad та As

136. Чим зумовлена іррадіація болю у вуха в пацієнтів після тонзилектомії?

- A. Приляганням верхнього констриктора глотки до псевдокапсули піднебінного мигдалика
- B. Приляганням трубно-глоткового м'яза до псевдокапсули піднебінного мигдалика
- C. Приляганням середнього констриктора глотки до псевдокапсули піднебінного мигдалика
- D. Приляганням м'яза натягувача піднебінної занавіски до псевдокапсули піднебінного мигдалика
- E. Приляганням м'яза язичка до псевдокапсули піднебінного мигдалика

137. Укажіть місце відкриття співустья лобової пазухи.

- A. Середній носовий хід
- B. Верхній носовий хід
- C. Загальний носовий хід
- D. -
- E. Нижній носовий хід

138. Пацієнт віком 40 років скаржиться на сильний біль у горлі, що посилюється під час ковтання, утруднення дихання, захриплість, кашель. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів, початок захворювання пов'язує з уживанням холодного молока. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 39,3°C, інспіраторна задишка. Під час пальпації ділянки гортані виявлено: болючість, хрящі гортані не рухомі, шийні лімфатичні вузли збільшені та болючі при пальпації. Під час непрямой ларингоскопії виявлено: гіперемія та інфільтрація слизової оболонки, набряк надгортанника, голосової щілини не видно. Інші ЛОР-органи - без патології. Який найімовірніший діагноз?

- A. Флегмонозний ларингіт
- B. Гострий тонзиліт
- C. Набряк гортані
- D. Хондроперихондрит
- E. Абсцес надгортанника

139. Пацієнт віком 20 років отримав удар по передній поверхні шиї. Через кілька годин з'явилися задишка та захриплість. Об'єктивно спостерігається: ажитований, тахікардія, інспіраторна задишка, дихання шумне, чутне на відстані, шкіра бліда, в акті дихання бере активну участь мускулатура грудної клітки, відзначається втягування надключичних, підключичних,

яремних ямок, міжреберних проміжків та епігастральної ділянки під час вдиху. Під час ларингоскопії виявлено: пухлиноподібне утворення лівого присінку гортані ціанотичного кольору, що перекриває голосову щілину. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гематома гортані
- B. Гострий хондроперихондрит гортані
- C. Гематома глотки
- D. Гострий ларингіт
- E. Перелом хрящів гортані

140. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C. Після проведеного обстеження встановлено діагноз: гострий тонзиліт. Результат обстеження за шкалою McIsaac становить 5 балів. Який антибактеріальний препарат необхідно призначити пацієнтці?

- A. Цефепім
- B. Амоксицилін
- C. Азитроміцин
- D. Норфлуксацин
- E. Гентаміцин

141. При яких хворобах вуха утворюється холестеатома?

- A. Гострому гнійному середньому отиті
- B. Хронічному доброякісному гнійному середньому отиті
- C. Хронічному злоякісному гнійному отиті, ателектатичному отиті
- D. Хронічному гнійному середньому отиті з центральною перфорацією
- E. Хронічному секреторному отиті

142. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано у стані вираженого оглушення. Збір анамнезу утруднений через тяжкий загальний стан пацієнта. Об'єктивно спостерігається: пульс - 106/хв, ЧД - 26/хв, сатурація - 94%, температура тіла - 38,2°C. Наявна ригідність потиличних м'язів та позитивний симптом Керніга з обох боків. З лівого вуха витікають виділення з неприємним запахом, після туалету вуха виявляється крайова перфорація в ненапруженій частині барабанної перетинки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Отосклероз
- B. Лівобічний хронічний середній отит, менінгіт
- C. Лівобічний хронічний епітимпаніт, лівобічний лабіринтит

D. Гостре порушення мозкового кровообігу

E. Хвороба Мен'єра

143. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 39°C. Під час орофарингоскопії виявлено: слизова оболонка ротової порожнини - яскраво-рожева, на нижній губі та щоках візуалізуються поодинокі афти, піднебінні мигдалики, піднебінні дужки та задня стінка глотки - яскраво-рожеві, набряклі. Передньо-шийні лімфатичні вузли збільшені, болючі, рухомі. Зі слів матері пацієнтки відомо, що аналогічні випадки трапляються періодично протягом останніх 2-х років. Який найімовірніший діагноз?

A. Рекурентний тонзиліт

B. Лептотрихоз

C. Афтозний стоматит

D. Синдром PFAPA

E. Хронічний фарингіт

144. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на постійне утруднення носового дихання через обидві половини носа, слизові виділення з носа, головний біль. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 5-ти років. Під час передньої риноскопії виявлено: слизова оболонка носа рожева, нижні носові раковини збільшені в об'ємі, носові ходи звужені, після змашування адреналіном раковини не зменшуються в розмірах і дихання через ніс не покращується. Інші ЛОР-органи без патології. Який найімовірніший діагноз?

A. Вазомоторний риніт (алергічна форма)

B. Вазомоторний риніт (нейровегетативна форма)

C. Хронічний катаральний риніт

D. Хронічний атрофічний риніт

E. Хронічний гіпертрофічний риніт

145. Яке оперативне втручання необхідно провести пацієнту з хронічним гнійним середнім епітимпанітом, ускладненим холестеатою, екстрадуральним абсцесом?

A. Тимпаноластику

B. Атикотомію з тимпанопластикою

C. Антромастоїдотомію

D. Стапедопластику

E. Розширену радикальну загальнопорожнинну операцію

146. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль у горлі, слабкість, підвищення

температури тіла до 38,5°C. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів. Об'єктивно спостерігається: під час пальпації шийні лімфатичні вузли збільшені, болісні, слизова оболонка ротоглотки гіперемована, піднебінні мигдалики збільшені та покриті нашаруванням. Укажіть кількість балів за Шкалою McIsaac, яка відповідає стану пацієнтки.

A. 5

B. 3

C. 1

D. 2

E. 4

147. Батьки однорічної дитини скаржаться, що посеред ночі в дитини розвинувся специфічний гавкаючий кашель, який переріс у задишку. Із анамнезу відомо, що за декілька днів до цього в дитини був нежить, закладений ніс, субфебрильна температура тіла. Об'єктивно виявлено: загальний стан дитини середньої тяжкості, шкіра бліда, ціанозу не виявлено. Під час вдиху в спокої спостерігається втягнення надгруднинного та міжреберних проміжків. Визначте ступінь тяжкості гострого стенозуючого ларинготрахеїту в дитини.

A. Середньої тяжкості

B. Тяжкого ступеня

C. Загроза дихальної недостатності

D. Легкого ступеня

E. Асфіксія

148. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на зниження слуху у правому вусі, гнійні виділення, біль у ділянці правого вуха. Із анамнезу відомо, що хворіє з дитинства після перенесеного кору, періодично відзначає загострення у вигляді гнійних та білих крошкоподібних виділень, що мають неприємний запах, прогресуюче погіршення слуху. Під час отоскопії спостерігається: незначні гнійні виділення в слуховому ході, барабанна перетинка перфорована у верхньому відділі, шепітна мова - 1,2 м, розмовна - 5,0 м. За результатами комп'ютерної томографії виявлено: деструктивні зміни головки молоточка, соскоподібний відросток склеротичного типу праворуч. Який найімовірніший діагноз?

A. Гострий правобічний середній отит

B. Правобічний хронічний мастоїдит

C. Правобічний хронічний лабіринтит

- D. Правобічний хронічний отит із холестоатомою**
- E. Правобічний хронічний гнійний мезотимпаніт**

149. Під час огляду пацієнта, якого шпиталізовано після побиття, виявлено утруднення носового дихання та деформацію піраміди носа. До побиття пацієнт не скаржився на носове дихання. На яке дослідження доцільно відправити пацієнта для підтвердження діагнозу: перелом кісток носа?

- A. Рентгенографію кісток носа**
- B. Риноманометрію**
- C. МРТ голови**
- D. Ендоскопічне дослідження порожнини носа**
- E. Рентгенографію придаткових пазух носа**

150. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на утруднене носове дихання, масивні водянисті виділення з носа, чхання. Із анамнезу відомо, що скарги з'являються щороку на початку липня. Під час передньої риноскопії виявлено: нижні носові раковини збільшені в об'ємі, носові ходи звужені, слизова оболонка носа ціанотична, місцями на ній визначаються білі плями. Встановлено діагноз: сезонний алергічний риніт. Яка тактика лікування в цьому разі?

- A. Промивання носа сольовим розчином, назальний кортикостероїд**
- B. Антибактеріальна терапія**
- C. Промивання носа сольовим розчином, в'яжучі антисептики до носа**
- D. Нестероїдні протизапальні препарати, судинозвужувальні препарати**
- E. Судинозвужувальні та секретолітичні препарати**